内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·感染性心内膜炎

感染　累及瓣膜　持续菌血症+赘生物脱落栓塞各系统
（性感认识：发热、心脏杂音、多系统损害）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类

①自体瓣膜心内膜炎：最常累及二尖瓣和主动脉瓣左边压力差大

②人工瓣膜心内膜炎：肠球菌和葡萄球菌是经导管人工瓣膜心内膜炎最常见的致病菌
（人工尝葡萄）　草绿色链球菌在人工瓣膜的感染中少见



金葡菌毒力强,可直接侵犯正常瓣膜
常见于急性感染性心内膜炎

小草(很弱,只侵犯已经发生病变的心瓣膜)

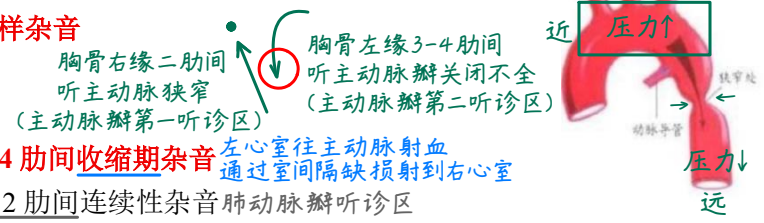
二、亚心炎发病的血流动力学因素 亚心炎发病率很高



1.瓣膜病最主要 关闭不全→射血和反流双重冲击,压力差大→血流快,细菌容易沉积

①主闭：胸骨左缘 3-4 肋间舒张期叹气样杂音 室间隔位置/心脏裸区/主动脉瓣第二听诊区

②二闭：心尖部收缩期吹风样杂音



2.其次是先心病

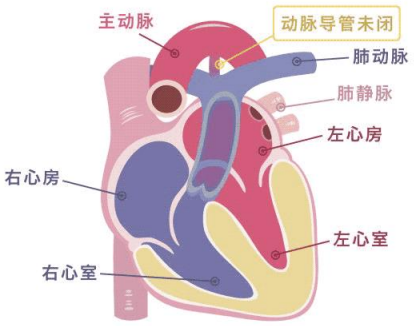
①室间隔缺损：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音 左心室往主动脉射血
通过室间隔缺损射到右心室

②动脉导管未闭：胸骨左缘 2 肋间连续性杂音 肺动脉瓣听诊区

③法洛四联症：室缺、主动脉骑跨、肺动脉狭窄、右心室肥厚（室友肥猪）

④主动脉缩窄（不是主动脉瓣狭窄）：上肢血压明显高于下肢 下肢血流量↓
狭窄不容易发生亚心炎
大部分发生于降主动脉

少见基础病：瓣膜狭窄（血流仍是一个方向）
压力差小
大面积室缺、房缺
心衰、房颤（瞎子大房间摔残了）往外周射血动力↓



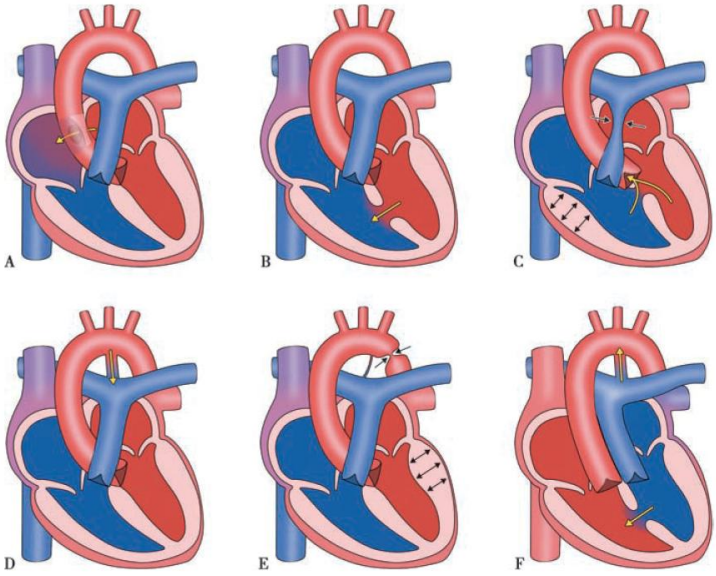
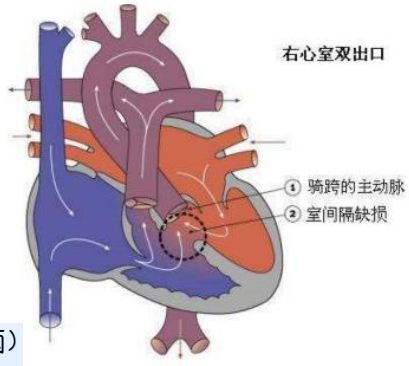


图 9-33　先天性心脏病示意图

A. 房间隔缺损；B. 室间隔缺损；C. 法洛四联症；D. 动脉导管未闭；E. 主动脉缩窄；F. 大动脉转位。



已有无菌性赘生物,要发生亚心炎,还需发生菌血症,菌血症来源(不同地方不同致病菌)
①拔牙时,口腔组织感染（草绿色链球菌）　拔草
②消化道、泌尿道、生殖道感染(G-杆菌常见)
③皮肤感染(葡萄球菌多见)

草绿色链球菌最常见,因其粘附性很强,很容易定居在无菌性赘生物中,导致亚心炎